

0. Algoritmo universal: 90 segundos antes de localizar el dolor

La intensidad no decide por sí sola una infiltración; mandan gravedad, función, sueño, progresión, fenotipo y preferencias.

Paso	Pregunta / acción	Si es positivo
1. Urgencia	Fiebre, inmunosupresión, cáncer, pérdida de peso, trauma, dolor nocturno no mecánico, articulación caliente, déficit progresivo, esfínteres/anestesia en silla de montar.	Detener algoritmo: estudio urgente, analítica/imágenes o derivación.
2. Fenotipo	¿Predomina dolor mecánico, inflamatorio, neuropático/radicular o nociplástico?	No mezclar tratamientos: nombrar el fenotipo dominante y los secundarios.
3. Generador	¿Qué postura, carga o movimiento reproduce y qué lo alivia? ¿Local, referido o dermatómico?	Formular 1 diagnóstico probable + 2 imitadores.
4. Función	¿Qué no puede hacer? ¿Duerme? ¿Camina? ¿Trabaja? ¿Qué objetivo concreto tiene?	Usar esa tarea como medida de respuesta, además de EVA/NRS.
5. Confirmación	¿La exploración y la imagen son concordantes? ¿Un bloqueo cambiaría la conducta?	Bloquear solo si el resultado positivo o negativo conduce a decisiones distintas.

SEMÁFORO	VERDE: dolor tolerable y función conservada → educación + ejercicio. ÁMBAR: dolor moderado/persistente o limita rehabilitación → optimizar diagnóstico, medicación breve y valorar intervención compartida. ROJO: dolor incapacitante, déficit, sospecha infecciosa/traumática/tumoral o fracaso con progresión → estudio/derivación prioritaria.
-----------------	---

Fenotipo	Pistas rápidas	No olvidar
Mecánico	Carga/movimiento dependiente, rigidez breve, mejora relativa con reposo o cambio de postura.	La imagen degenerativa puede ser incidental.
Inflamatorio	Rigidez matutina prolongada, reposo empeora, calor/tumefacción, síntomas sistémicos.	Cristales, infección y enfermedad reumática.
Neuropático/radicular	Quemazón, descarga, parestesias, alodinia; distribución neuroanatómica y signos neurológicos.	Dolor referido no equivale a radiculopatía.
Nociplástico	Dolor desproporcionado/difuso, hipersensibilidad, sueño/fatiga, múltiples síntomas.	Evitar escalada de técnicas sobre hallazgos incidentales.